Plano de Contingência e Ação no Município de Condor – RS para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19)

Município de Condor

Março de 2020

Versão 1 (26/_03_/2020)

INTRODUÇÃO

Na data de 30 de janeiro do ano corrente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência em Saúde Pública devido à doença respiratória classificada como COVID-19, conforme casos detectados inicialmente na China e que se espalhou gradativamente por todo o mundo, chegando ao Brasil no último mês de fevereiro. Considerando que atualmente o Brasil encontra-se em fase de mitigação da epidemia em um cenário de transmissão comunitária e considerando as recomendações da OMS e do Ministério da Saúde (MS), o município de Condor do Estado do Rio Grande do Sul, através de orientações recebidas pela 17ª CRS/SES-RS elaborou o referido Plano de Contingência e Ação para o enfrentamento à COVID-19.

Centro de Operações de Emergências para COVID-19

Os profissionais responsáveis pela elaboração e ações imediatas de contingência para o COVID-19 formarão o Centro de Operações de Emergências para COVID-19 (COE Municipal), e estão descritos no quadro abaixo:

Composição COE Municipal			
NOME	**CARGO**	**SETOR**	**ÓRGÃO**
Silvane Mass Carvalho	Enfermeira	Vigilância epidemiológica	SMS
Liziane Obermann	Enfermeira	CCIH	Hospital de Condor
Luis Ernesto Viquez Vargas	Médico	Diretor Clinico Hospital e Diretor Clinico Centro Integrado de Saúde	SMS Hospital de Condor
Antonio Luiz Teixeira Candido	Secretário de Saúde	Gabinete	SMS

SITUAÇÃO 1: Presença de caso suspeito no Município

As ações pertinentes devem ser desencadeadas a partir da definição de caso suspeito de Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), que no momento atual

é:

Caso 1 – SÍNDROME GRIPAL (SG): Paciente com febre de início súbito (≥ 37,8°C) mesmo que referida, acompanhada de tosse OU dor de garganta E pelo menos um dos sintomas: mialgia, cefaleia ou artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico.

Crianças < 2 anos: febre de início súbito e sintomas respiratórios: tosse, coriza e obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.

Obs: febre pode não estar presente em alguns casos excepcionais, como crianças, idosos, imunossuprimidos ou pessoas que utilizaram antitérmicos e, portanto, a avaliação clínica e epidemiológica deve ser levada em consideração.

Caso 2 – SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): Indivíduo de qualquer idade, com síndrome gripal (conforme definição anterior) e que apresente dispneia ou os seguintes sinais de gravidade:

- Saturação de SpO2 <95% em ar ambiente;
- Sinais de desconforto respiratório ou aumento da frequência respiratória avaliada de acordo com a idade;
- Piora nas condições clínicas de doença de base;
- Hipotensão em relação à pressão arterial habitual do paciente;
- Em crianças: além dos itens anteriores, observar batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência.

Gestão	Atividade	Ação (como fazer?)
	Referência municipal para contato: Enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica – Silvane Mass Carvalho	O manejo clínico da Síndrome Gripal na APS/ESF difere frente a gravidade dos casos. Para casos leves, inclui medidas de suporte e conforto, isolamento domiciliar e monitoramento até alta do isolamento. Para casos graves, inclui a estabilização clínica e o encaminhamento e transporte a centros de referência ou serviço de urgência/emergência ou hospitalares. O manejo diagnóstico e terapêutico de pessoas com suspeita de infecção respiratória caracterizada como Síndrome Gripal,
	Garantir insumos estratégicos	
	Detalhar fluxo de atendimento para casos leves, moderados e graves (Anexo 1)	
	Porta-voz responsável pela interlocução com veículos de comunicação: Médico Luis Ernesto Viquez Vargas	

		causada ou não por COVID-19, no contexto da APS/ESF incluiu os passos a seguir: 1. Identificação de caso suspeito de Síndrome Gripal e de COVID-19 2. Medidas para evitar contágio na UBS 3. Estratificação da gravidade da Síndrome Gripal 4. Casos leves: manejo terapêutico e isolamento domiciliar 5. Casos graves: estabilização e encaminhamento a serviços de urgência/emergência ou hospitalares 6. Notificação Compulsória Imediata para casos de SRAG 7. Monitoramento clínico 8. Medidas de prevenção comunitária e apoio à vigilância ativa
Vigilância em Saúde	Notificar imediatamente a 17ª CRS/SES-RS	O serviço de saúde deve realizar medidas para garantir que todos os casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) ou outra infecção respiratória (por exemplo, febre e tosse) sigam os procedimentos de higiene respiratória, etiqueta da tosse e higiene das mãos durante todo o período que permanecerem na unidade. Serão utilizados alertas visuais (por exemplo, cartazes, placas e pôsteres) na entrada dos serviços de saúde e em locais estratégicos (por exemplo, áreas de espera, elevadores e lanchonetes) para fornecer aos pacientes e acompanhantes/visitantes as instruções sobre higiene das mãos, higiene respiratória e
	Monitorar e manter registro atualizado dos casos suspeitos	
	Monitorar e manter registro atualizado dos contatos próximos	

		etiqueta da tosse. Será mantido controle isolamento domiciliar de 14 dias em casos de síndrome gripal leve e de seus contactantes.
Laboratório	Elaborar fluxo de local de coleta e encaminhamento de amostra de exame (seguir as orientações do manual de coleta e envio de amostra ao LACEN)	Para todos os casos confirmados como suspeitos deverá ser realizada a coleta de material a ser enviada ao LACEN para análise. A coleta de material deverá ser feita tanto nas unidades de saúde quanto em ambiente hospitalar, dependendo da porta de entrada que o paciente procurar, inclusive no seu domicílio, nos casos de isolamento domiciliar. Em qualquer das situações acima, os profissionais de saúde deverão seguir a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA – Orientações para Serviços de Saúde: Medidas de Prevenção e Controle que Devem ser Adotadas Durante a Assistência aos Casos Suspeitos ou Confirmados de Infecção pelo Novo Coronavírus (COVID-19). É necessária a coleta de 3 amostras respiratórias (1 kit do swab). As coletas devem seguir o protocolo de Influenza na suspeita do novo Coronavírus (COVID-19) . A amostra será encaminhada com urgência para o LACEN. O LACEN entrará em contato com a CGLAB para solicitação do transporte. Uma das amostras será enviada ao Centro Nacional de Influenza (NIC) e outra amostra será enviada para análise de metagenômica. Cadastrar na requisição de solicitação de

		exame no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), no preenchimento do campo "Agravo/Doença", selecionar a opção "Coronavírus". As amostras deverão estar acompanhadas da requisição do GAL. A distribuição dos kits de coleta será realizada pelo LACEN. O município deverá solicitar à 17ª Coordenadoria Regional de Saúde o quantitativo necessário, a qual fará a solicitação dos kits ao LACEN para distribuição. O monitoramento dos casos suspeitos e dos contactantes será por 14 dias. O número de profissionais de saúde envolvidos deve ser o menor possível. As orientações aos profissionais de saúde que atenderão o caso deverão seguir as orientações do protocolo do Ministério da Saúde.
Assistência	Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de caso suspeito	Identificar precocemente pacientes suspeitos através do agente sentinela que ficará na entrada da UBS. • Pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em que forem identificados na triagem até sua chegada ao local de isolamento, que deve ocorrer o mais rápido possível. • A Vigilância Epidemiológica do município em questão deve ser notificada por telefone e deverá ser preenchida a ficha SIVEP GRIPE SRAG para Hospitais. • Qualquer pessoa que entrar em contato com o
	Notificar imediatamente	
	Organização do fluxo de atendimento para casos suspeitos, priorizando o isolamento domiciliar nos casos leves (Anexo 2)	
	Orientar os profissionais dos serviços de saúde e a população sobre as medidas individuais e coletivas de prevenção e controle para o COVID-19	
	Elaborar fluxo de transporte pré-hospitalar e inter-hospitalar para itinerários do paciente nos casos moderados e graves	

		caso suspeito deve utilizar EPI (preferencial máscara n95, nas exposições por um tempo mais prolongado e procedimentos que gerem aerossolização; eventualmente máscara cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco; protetor ocular ou protetor de face; luvas; capote/avental). • Realizar higiene de mãos, respeitando os cinco momentos de higienização.
Assistência Farmacêutica	Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes. Garantir o acesso a medicamentos de uso contínuo para o tratamento de doenças crônicas.	A Farmácia Municipal deverá: - Disponibilizar medicamentos indicados ao tratamento para os casos de SG, conforme receita médica. - Disponibilizar fosfato de oseltamivir (Tamiflu) aos casos indicados, conforme receita médica. - Padronizar a dispensação de medicamentos de uso contínuo para doenças crônicas com validade da receita de 12 meses e para medicamentos de receita controlada com validade de 3 meses, evitando o deslocamento da população até a unidade para troca de receitas.

SITUAÇÃO 2: Presença de caso confirmado no Município:

Gestão	**Atividade**	**Ação (como fazer?)**
	Referência municipal para contato: Enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica – Silvane Mass Carvalho	Avaliar a gravidade do quadro clínico e seguir orientações em relação ao transporte e internação dos casos suspeitos graves de acordo com a regulação local e estadual. Os
	Garantir insumos estratégicos	

	Detalhar fluxo de atendimento para casos leves, moderados e graves (Anexo 1)	hospitais de referência Regional estão indicados no Plano de Contingência Estadual. Em caso de pacientes com sinais de gravidade removidos aos hospitais Regionais orientados pelas equipes de regulação Municipais/ 17ª CRS/ Estadual, manter o paciente em isolamento seguindo protocolo do Ministério da Saúde (precaução padrão e de contato e para gotículas, precaução para aerossóis no caso de procedimentos com possível aerossolização); 8.2 Em caso de pacientes com quadro sem gravidade o Serviço de Saúde orienta isolamento domiciliar até a resolução completa dos sintomas e recomendações de cuidados seguindo protocolo do Ministério da Saúde. Monitorar e avaliar contatos, mantendo em isolamento de acordo com a classificação do caso.
	Porta-voz responsável pela interlocução com veículos de comunicação: Médico Luis Ernesto Viquez Vargas	
Vigilância em Saúde	Notificar imediatamente a 17ª CRS/SES-RS	O serviço de saúde deve realizar medidas para garantir que todos os casos suspeitos ou confirmados, de infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) ou outra infecção respiratória (por exemplo, febre e tosse) sigam os procedimentos de higiene respiratória, etiqueta da tosse e higiene das mãos, realizar monitoramento do caso, será mantido controle isolamento domiciliar de 14 dias em casos de síndrome gripal leve e de seus contactantes.
	Monitorar e manter registro atualizado dos casos suspeitos e confirmados	
	Monitorar e manter registro atualizado dos contatos próximos	
Laboratório	Elaborar fluxo de local de coleta e encaminhamento de amostra de exame (seguir	Para todos os casos confirmados como suspeitos deverá ser realizada a coleta

	as orientações do manual de coleta e envio de amostra ao LACEN)	de material a ser enviada ao LACEN para análise. A coleta de material deverá ser feita tanto nas unidades de saúde quanto em ambiente hospitalar, dependendo da porta de entrada que o paciente procurar, inclusive no seu domicílio, nos casos de isolamento domiciliar. Em qualquer das situações acima, os profissionais de saúde deverão seguir a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA – Orientações para Serviços de Saúde: Medidas de Prevenção e Controle que Devem ser Adotadas Durante a Assistência aos Casos Suspeitos ou Confirmados de Infecção pelo Novo Coronavírus (COVID-19). É necessária a coleta de 3 amostras respiratórias (1 kit do swab). As coletas devem seguir o protocolo de Influenza na suspeita do novo Coronavírus (COVID-19) . A amostra será encaminhada com urgência para o LACEN. O LACEN entrará em contato com a CGLAB para solicitação do transporte. Uma das amostras será enviada ao Centro Nacional de Influenza (NIC) e outra amostra será enviada para análise de metagenômica. Cadastrar na requisição de solicitação de exame no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), no preenchimento do campo "Agravo/Doença", selecionar a opção "Coronavírus". As amostras deverão estar acompanhadas da requisição do GAL. A distribuição dos kits de

		coleta será realizada pelo LACEN. O município deverá solicitar à 17ª Coordenadoria Regional de Saúde o quantitativo necessário, a qual fará a solicitação dos kits ao LACEN para distribuição. O monitoramento dos casos suspeitos e dos contactantes será por 14 dias. O número de profissionais de saúde envolvidos deve ser o menor possível. As orientações aos profissionais de saúde que atenderão o caso deverão seguir as orientações do protocolo do Ministério da Saúde.
Assistência	Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de caso suspeito e confirmado	Identificar precocemente pacientes suspeitos através do agente sentinela que ficará na entrada da UBS. • Pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em que forem identificados na triagem até sua chegada ao local de isolamento, que deve ocorrer o mais rápido possível. • A Vigilância Epidemiológica do município em questão deve ser notificada por telefone e deverá ser preenchida a ficha SIVEP GRIPE SRAG para Hospitais. • Qualquer pessoa que entrar em contato com o caso suspeito deve utilizar EPI (preferencial mscara n95, nas exposições por um tempo mais prolongado e procedimentos que gerem aerossolização; eventualmente máscara
	Notificar imediatamente o caso suspeito	
	Organização do fluxo de atendimento para casos suspeitos e confirmados, priorizando o isolamento domiciliar nos casos leves (Anexo 2)	
	Orientar os profissionais dos serviços de saúde e a população sobre as medidas individuais e coletivas de prevenção e controle para o COVID-19	
	Elaborar fluxo de transporte pré-hospitalar e inter-hospitalar para itinerários do paciente nos casos moderados e graves	

		cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco; protetor ocular ou protetor de face; luvas; capote/avental). • Realizar higiene de mãos, respeitando os cinco momentos de higienização.
Assistência Farmacêutica	Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes. Garantir o acesso a medicamentos de uso contínuo para o tratamento de doenças crônicas.	A Farmácia Municipal deverá: - Disponibilizar medicamentos indicados ao tratamento para os casos de SG, conforme receita médica. - Disponibilizar fosfato de oseltamivir (Tamiflu) aos casos indicados, conforme receita médica. - Padronizar a dispensação de medicamentos de uso contínuo para doenças crônicas com validade da receita de 12 meses e para medicamentos de receita controlada com validade de 3 meses, evitando o deslocamento da população até a unidade para troca de receitas.

SITUAÇÃO 3: Presença de caso confirmado com transmissão local no Município:

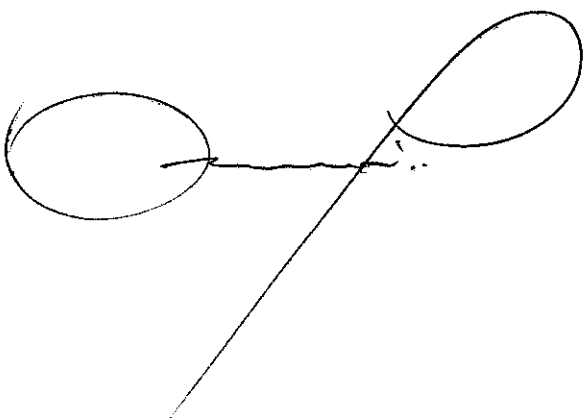
Gestão	**Atividade**	**Ação (como fazer?)**
	Referência municipal para contato: Enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica - Silvane Mass Carvalho	O serviço de saúde deve realizar medidas para garantir que todos os casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) ou outra infecção respiratória (por exemplo, febre e tosse) sigam os procedimentos de higiene respiratória, etiqueta da tosse e higiene das mãos durante todo o período que permanecerem na unidade,
	Garantir insumos estratégicos	
	Detalhar fluxo de atendimento para casos leves, moderados e graves	
	Porta-voz responsável pela interlocução com veículos de	

	comunicação: Médico Luis Ernesto Viques Vargas	além de intensificar as ações que promovam isolamento social. Serão utilizados alertas visuais (por exemplo, cartazes, placas e pôsteres) na entrada dos serviços de saúde e em locais estratégicos (por exemplo, áreas de espera, elevadores e lanchonetes) para fornecer aos pacientes e acompanhantes/visitantes as instruções sobre higiene das mãos, higiene respiratória e etiqueta da tosse. Será mantido controle isolamento domiciliar de 14 dias em casos confirmados de COVID-19 e de seus contactantes.
Vigilância em Saúde	Notificar imediatamente a regional de saúde	No contexto de transmissão comunitária e abordagem sindrômica - Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave - , não se deve realizar notificação de casos. A notificação de caso passa a acontecer nas Unidades de Atenção Primária que já fazem parte da Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal e nos casos de SRAG atendidos em serviços de urgência/emergência ou hospitalares.
	Monitorar e manter registro atualizado dos casos suspeitos e confirmados	
	Monitorar e manter registro atualizado dos contatos próximos	
Laboratório	Elaborar fluxo de local de coleta e encaminhamento de amostra de exame (seguir as orientações do manual de coleta e envio de amostra ao LACEN)	Para todos os casos confirmados como suspeitos deverá ser realizada a coleta de material a ser enviada ao LACEN para análise. A coleta de material deverá ser feita tanto nas unidades de saúde quanto em ambiente hospitalar, dependendo da porta de entrada que o paciente procurar, inclusive no seu domicílio, nos casos de isolamento domiciliar. Em qualquer das situações

		acima, os profissionais de saúde deverão seguir a Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA - Orientações para Serviços de Saúde: Medidas de Prevenção e Controle que Devem ser Adotadas Durante a Assistência aos Casos Suspeitos ou Confirmados de Infecção pelo Novo Coronavírus (COVID-19). É necessária a coleta de 3 amostras respiratórias (1 kit do swab). As coletas devem seguir o protocolo de Influenza na suspeita do novo Coronavírus (COVID-19) . A amostra será encaminhada com urgência para o LACEN. O LACEN entrará em contato com a CGLAB para solicitação do transporte. Uma das amostras será enviada ao Centro Nacional de Influenza (NIC) e outra amostra será enviada para análise de metagenômica. Cadastrar na requisição de solicitação de exame no Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), no preenchimento do campo "Agravo/Doença", selecionar a opção "Coronavírus". As amostras deverão estar acompanhadas da requisição do GAL. A distribuição dos kits de coleta será realizada pelo LACEN. O município deverá solicitar à 17ª Coordenadoria Regional de Saúde o quantitativo necessário, a qual fará a solicitação dos kits ao LACEN para distribuição. O

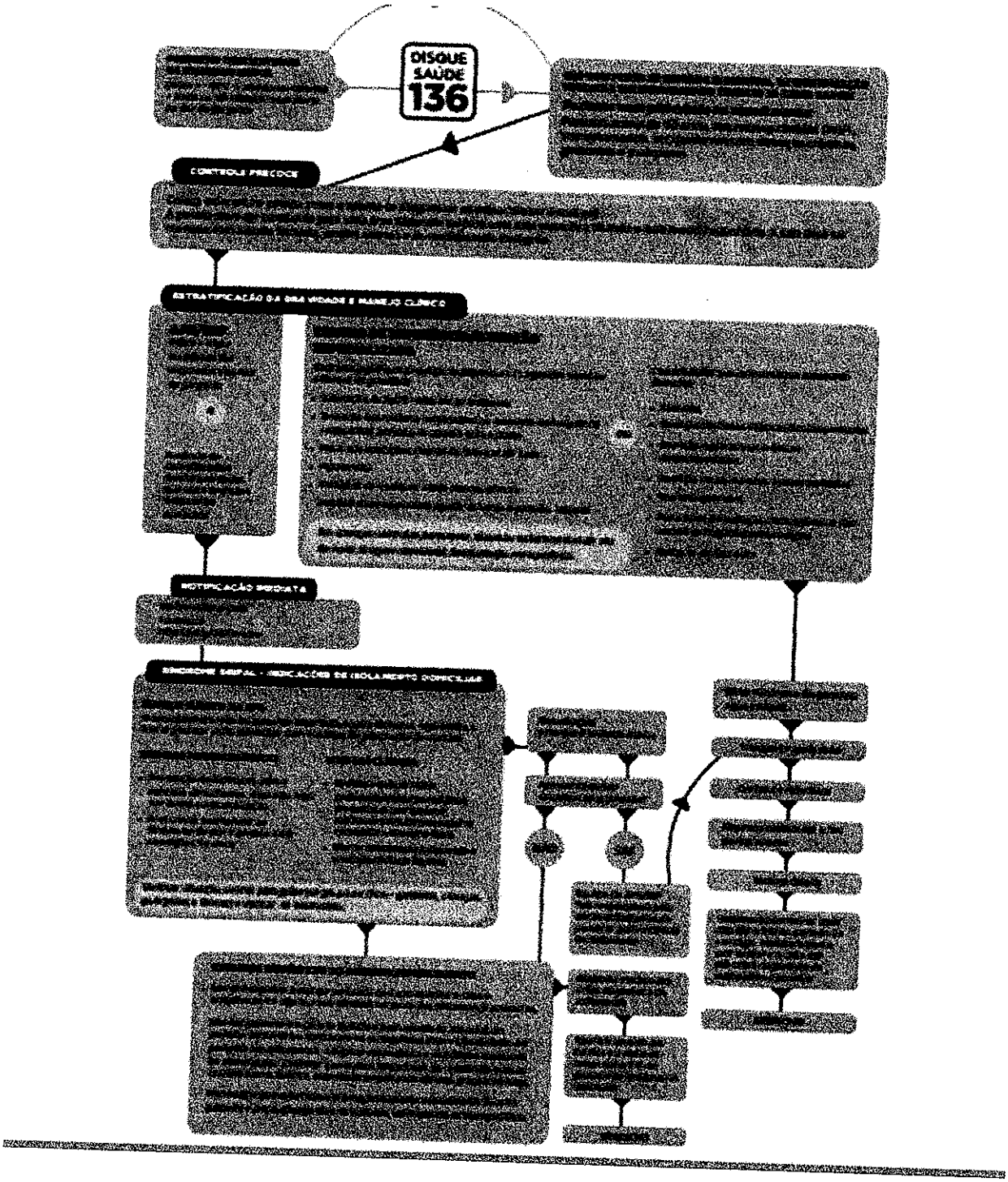
		monitoramento dos casos suspeitos e dos contactantes será por 14 dias. O número de profissionais de saúde envolvidos deve ser o menor possível. As orientações aos profissionais de saúde que atenderão o caso deverão seguir as orientações do protocolo do Ministério da Saúde.
Assistência	Garantir acolhimento, reconhecimento precoce e controle de caso suspeito e confirmado	Identificar precocemente pacientes suspeitos através do agente sentinela que ficará na entrada da UBS. • Pacientes suspeitos devem utilizar máscara cirúrgica desde o momento em que forem identificados na triagem até sua chegada ao local de isolamento, que deve ocorrer o mais rápido possível. • A Vigilância Epidemiológica do município em questão deve ser notificada por telefone e deverá ser preenchida a ficha SIVEP GRIPE SRAG para Hospitais. • Qualquer pessoa que entrar em contato com o caso suspeito deve utilizar EPI (preferencial máscara n95, nas exposições por um tempo mais prolongado e procedimentos que gerem aerossolização; eventualmente máscara cirúrgica em exposições eventuais de baixo risco; protetor ocular ou protetor de face; luvas; capote/avental). • Realizar higiene de mãos, respeitando os cinco
	Notificar imediatamente o caso confirmado	
	Organização do fluxo de atendimento para casos suspeitos e confirmados, priorizando o isolamento domiciliar nos casos leves	
	Orientar os profissionais dos serviços de saúde e a população sobre as medidas individuais e coletivas de prevenção e controle para o COVID-19	
	Elaborar fluxo de transporte pré-hospitalar e inter-hospitalar para itinerários do paciente nos casos moderados e graves	

		momentos de higienização.
Assistência Farmacêutica	Garantir estoque estratégico de medicamentos para atendimento sintomático dos pacientes. Garantir o acesso a medicamentos de uso contínuo para o tratamento de doenças crônicas.	A Farmácia Municipal deverá: - Disponibilizar medicamentos indicados ao tratamento para os casos de SG, conforme receita médica. - Disponibilizar fosfato de oseltamivir (Tamiflu) aos casos indicados, conforme receita médica. - Padronizar a dispensação de medicamentos de uso contínuo para doenças crônicas com validade da receita de 12 meses e para medicamentos de receita controlada com validade de 3 meses, evitando o deslocamento da população até a unidade para troca de receitas.

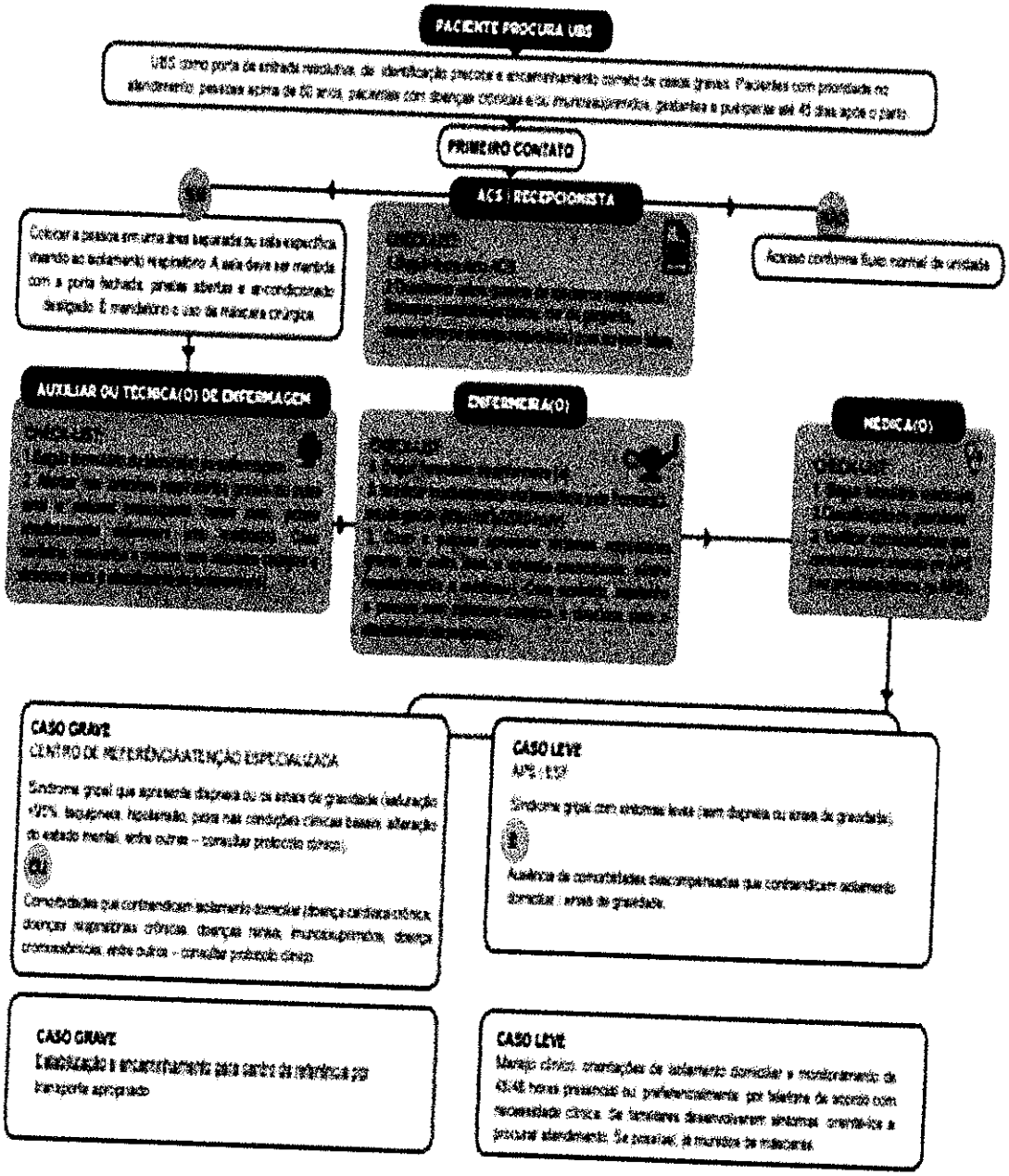


ANEXOS

ANEXO 1



Anexo 2


PACIENTE PROCURA UBS
PRIMEIRO CONTATO
ACS / RECEPCIONISTA
AUXILIAR OU TECNICA(O) DE ENFERMAGEM
ENFERMEIRA(O)
MEDICA(O)
CASO GRAVE
CASO LEVE
CASO GRAVE
CASO LEVE

BIBLIOGRAFIA

As referencias teóricas a serem seguidas para auxiliar na elaboração do Plano de Contingência Municipal estão contidas nos seguintes links atualizados periodicamente:

- https://coronavirus.saude.gov.br/

- https://saude.rs.gov.br/coronavirus

- Nota Informativa COE-RS/SES-RS de 23 de março de 2020.

- Protocolo de manejo clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde. Versão 5. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Março de 2020. Brasília – DF.

Antonio L. T. Candido
Secretário Municipal da Saúde
Condor - RS